

Zaburzenie psychiczne — *nie dieta, nie wybór*

AN to choroba o najwyższej śmiertelności wśród zaburzeń psychicznych. Nie jest „dieta”, nie jest „próbą zwrócenia uwagi”, nie jest „stylem życia”.

CZAS: 20 min psychoedukacji **REALIZACJA:** pierwsze sesje + edukacja rodziny

ŹRÓDŁO: APA (2013, DSM-5; 2022, DSM-5-TR); WHO (2022, ICD-11, kod 6B80); Bulik (2017, *Midlife Eating Disorders*); Arcelus i in. (2011, metaanaliza śmiertelności, SMR = 5,86)

JAK UŻYWAĆ

W sekcji 01 — **trzy rdzenie diagnostyczne** AN według DSM-5-TR i ICD-11. W sekcji 02 — **pięć powszechnych mitów** i co mówi nauka. Sekcja 03 — **twoja praca:** pierwsze rozpoznania, sygnały, kiedy szukać pomocy. Sekcja 04 — kluczowe liczby i kontakty.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Anoreksja psychiczna (ang. *anorexia nervosa*) to zaburzenie psychiczne, *nie* dieta ani „styl życia”. Trzy kryteria DSM-5-TR (APA, 2022): *restrykcja* energii prowadząca do znacznie niskiej masy, *intensywny lęk* przed przyrostem wagi, *zaburzenie obrazu ciała*. Śmiertelność jest najwyższa wśród zaburzeń psychicznych (Arcelus i in., 2011, *Arch Gen Psychiatry*) — głównie z powodu powikłań medycznych i samobójstw. Wczesna identyfikacja i interwencja są warunkiem dobrego rokowania.

01 Trzy rdzenie diagnostyczne (DSM-5-TR / ICD-11)

1 · RESTRYKCJA → NISKA MASA

Istotnie niska masa ciała w kontekście wieku, płci, trajektorii rozwoju i zdrowia. Klinicznie znaczące *niedożywienie*, nie sama waga jako liczba.

2 · LĘK PRZED PRZYTYCIEM

Intensywny lęk przed przytyciem lub uporczywe zachowania uniemożliwiające przytycie — nawet przy bardzo niskiej masie. Często paradoksalnie *nasilający się* w trakcie leczenia.

3 · ZABURZONY OBRAZ CIAŁA

Nadwartościowanie wagi i kształtu w samoocenie, lub uporczywy *brak wglądu* w powagę niskiej masy. „Nie widzę problemu, mimo że inni są w panice”.

MIT

CO MÓWI NAUKA

„AN to musi być bardzo niska waga”

Fałsz. Atypowa AN spełnia wszystkie kryteria poza niską masą, z tymi samymi powikłaniami medycznymi (Whitelaw, 2014).

„AN to problem nastolatków”

Fałsz. Wszystkie grupy wiekowe — występuje także w wieku dorosłym i u osób starszych (Bulik, 2017, *Midlife Eating Disorders*).

„AN dotyczy tylko kobiet”

Fałsz. Około 25% przypadków to mężczyźni (Mitchison & Mond, 2015). Niedodiagnozowanie u mężczyzn jest istotnym problemem klinicznym.

„AN to wybór, można po prostu zacząć jeść”

Fałsz. AN ma solidne podłoże *neurobiologiczne* — heritability 50–60% (Bulik i in., 2006); niedożywienie zmienia funkcjonowanie mózgu.

„AN jest nieuleczalna”

Fałsz. Pełna remisja u 40–60% pacjentów (Steinhausen, 2002, metaanaliza). Wczesna interwencja istotnie poprawia rokowanie.

SYGNAŁY, KTÓRE OBSERWUJĘ U SIEBIE/BLISKIEGO

— restrykcja jedzenia, lęk wagi, ważenie wielokrotnie, ćwiczenia kompensacyjne, zniknięcia po posiłkach

SYGNAŁY SOMATYCZNE

— zmiany wagi w czasie, sen, energia, koncentracja, miesiączka u kobiet

MÓJ PIERWSZY KROK

— wizyta u lekarza pierwszego kontaktu, konsultacja psychiatryczna, ośrodek leczenia zaburzeń odżywiania

MOJA SIEĆ WSPARCIA

— zaufana osoba, do której mogę się zwrócić; ktoś, kto pomoże mi zacząć rozmowę z profesjonalistą

Klucz: AN *nie* jest „wyborem” ani „słabością charakteru” — jest **chorobą**, którą się leczy. Anoreksja ma *najwyższą śmiertelność* spośród wszystkich zaburzeń psychicznych (Arcelus i in., 2011: SMR = 5,86 wobec populacji ogólnej) — dwukrotnie wyższą niż w depresji. Przyczyny: powikłania medyczne niedożywienia i samobójstwa. *Nie czekaj*, aż „*będzie wystarczająco źle*” — utrata wagi większa niż 15% w 6 miesięcy lub większa niż 25% w roku jest sygnałem alarmowym *niezależnie* od wagi wyjściowej. Wczesna interwencja istotnie poprawia rokowanie: pełna remisja jest możliwa u 40–60% pacjentów (Steinhausen, 2002), ale szanse maleją wraz z czasem trwania choroby. Wina *nie* leży po stronie pacjenta ani rodziny — etiologia jest wieloczynnikowa: biologiczna, psychologiczna, środowiskowa. Leczenie wymaga zespołu: lekarz pierwszego kontaktu lub pediatra, psychiatrę, dietetyk kliniczny i psychoterapeuta z doświadczeniem w zaburzeniach odżywiania.

△ Linia wsparcia: 116 123 (dorośli, 24/7), 116 111 (młodzież, codziennie). Ogólnopolska Linia Pomocy „Pokonaj Bulimię i Anoreksję”: informacja w lokalnym ośrodku zdrowia psychicznego. W sytuacji omdleń, kołatania serca, znaczącego osłabienia — pilna konsultacja medyczna (SOR), *nie czekaj na wizytę planową*.